

Revista Argentina de Clínica Psicológica

ISSN N° 0327-6716

**Presentación de un instrumento para la detección y valoración
de las preocupaciones hipocondríacas en la población general:**

El Inventario de Preocupaciones Hipocondríacas Aiglé (IPHA)

Amparo Belloch (España), Héctor Fernández-Álvarez y
Claudia Castañeiras (Argentina)

Depresión y discordia marital

Silvia Franchi (Argentina)

**Stroop Emocional: Evaluación de Sesgos Cognitivos y Procesamiento
Selectivo de la Información en Pacientes con Trastornos de Ansiedad**

Sergio Lo Tauro (Argentina)

Metáforas de la terapia

Juan M. Molinari (Argentina)

**La interacción entre las intervenciones psicoterapéuticas de distintos
marcos teóricos y los factores comunes a las psicoterapias**

Vanina Waizmann, Ignacio Etchebarne y Andrés J. Roussos (Argentina)

Breves Aportes de Profesionales a la Clínica

Una perspectiva humanista en psicoterapia

Octavio Fernández Moujan (Argentina)

Psicoterapia en Grecia:

Desde sus orígenes hasta sus avances recientes

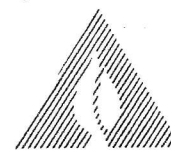
Vassiliki Pattakou-Parassiri y Argyroula E. Kalaitzaki (Grecia)

❖

Entrevista a Mauricio Goldenberg (Argentina)

❖

Actualización Bibliográfica



Fundación AIGLE

REVISTA ARGENTINA DE CLINICA PSICOLOGICA
La REVISTA ARGENTINA DE CLINICA PSICOLOGICA es una publicación cuatrimestral de
FUNDACION AIGLE

DIRECTORA-EDITORIA
Lilian Corrado

CONSULTORES EDITORIALES

AVILA ESPADA, Alejandro	(España)
BARINGOLTZ, Sara	(Argentina)
BELLOCH FUSTER, Amparo	(España)
BENJAMIN, Lorna	(U.S.A.)
BERNAL, Guillermo	(Puerto Rico)
BEUTLER, Larry	(U.S.A.)
BOTELLA, Cristina	(España)
CANCINI, Luigi	(Italia)
CASTILLA DEL PINO, Carlos	(España)
CHAPPA, Herbert	(Argentina)
FEIXAS, Guillem	(España)
FERNANDEZ-ALVAREZ, Héctor	(Argentina)
FERNANDEZ MOUJAN, Octavio	(Argentina)
FREEMAN, Arthur	(U.S.A.)
GOLDFRIED, Marvin	(U.S.A.)
GREENBERG, Leslie	(Canadá)
HIRSCH, Hugo	(Argentina)
JUTORAN, Sara	(Argentina)
MAHONEY, Michael	(U.S.A.)
MUCHINIK, Eva	(Argentina)
OPAZO, Roberto	(Chile)
OSTROV, Amelie HINTERMEYER de	(Argentina)
PASCUAL LEONE, Juan	(Canadá)
PEREZ GOMEZ, Augusto	(Colombia)
PEYRU, Graciela	(Argentina)
PUGET, Janine	(Argentina)
ROMAN, Néstor	(Argentina)
ROSENBAUM, Max	(U.S.A.)
SAFRAN, Jeremy	(U.S.A.)
SEMERARI, Antonio	(Italia)
SERRONI COPELLO, Raúl	(Argentina)
STEINGLASS, Peter	(U.S.A.)
WACHTEL, Paul	(U.S.A.)
WINKLER, María Inés	(Chile)
ZURETTI, Mónica	(Argentina)

Los artículos de la Revista Argentina de Clínica Psicológica están indexados en PsycINFO, PSICODOC,
LILACS y E-Psyche database.

Valores de suscripción:	Argentina:	Indiv.: \$ 50.-	Inst.: \$ 65.-
	Latinoamérica:	Indiv.: \$ 140.-	Inst.: \$ 180.-
	Otros países:	Indiv.: \$ 155.-	Inst.: \$ 190.-
	Precio del ejemplar:	\$20.-	
Subscription rates:	Latin America:	Indiv.: \$ 140.-	Inst.: \$ 180.-
	Other countries:	Indiv.: \$ 155.-	Inst.: \$ 190.-

ISSN N° 0327-6716
Registro Nacional de la Propiedad Intelectual N° 251.844
Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723
Franqueo Pagado Concesión N° 5273 Correo Argentino Central (B)
©2004 FUNDACION AIGLE. Virrey Olaguer y Feliú 2679 (C1426EBE) Bs. As. Argentina
Tel.: (54 - 11) 4781-3897 / Fax.: (54 - 11) 4784-3563 - E-mail: fundacion@aigle.org.ar
Producción gráfica: Aigle Ediciones. Virrey Olaguer y Feliú 2679 (C1426EBE) Bs. As. Argentina
Tel.: (54 - 11) 4781-3897 / Fax.: (54 - 11) 4784-3563
E-mail: fundacion@aigle.org.ar Página Web: <http://www.aigle.org.ar>

Indice

Artículos

Presentación de un instrumento para la detección y valoración de las preocupaciones hipocondríacas en la población general: el Inventario de Preocupaciones Hipocondríacas Aiglé (IPHA).

Amparo Belloch (España), Héctor Fernández-Álvarez y
Claudia Castañeiras (Argentina).....183-195

Depresión y discordia marital

Silvia Franchi (Argentina).....197-203

Stroop Emocional: Evaluación de Sesgos Cognitivos y Procesamiento Selectivo de la Información en Pacientes con Trastornos de Ansiedad

Sergio Lo Tauro (Argentina).....205-224

Metáforas de la terapia

Juan M. Molinari (Argentina).....225-231

La interacción entre las intervenciones psicoterapéuticas de distintos marcos teóricos y los factores comunes a las psicoterapias

Vanina Waizmann, Ignacio Etchebarne y
Andrés J. Roussos (Argentina).....233-244

Breves Aportes de Profesionales a la Clínica

Una perspectiva humanista en psicoterapia

Octavio Fernández Moujan (Argentina).....245-249

Psicoterapia en diferentes países

Psicoterapia en Grecia: Desde sus orígenes hasta sus avances recientes

Vassiliki Pattakou-Parassiri y Argyroula E. Kalaitzaki (Grecia).....251-264

Entrevista

Entrevista a Mauricio Goldenberg (Argentina)

Lilian Corrado (Argentina).....265-274

Actualización bibliográfica.....275-293

Contents

Articles

*Development of an instrument for the detection and
valoration of hypochondriacal worries in general population:*

The Inventory of Hypochondriacal Concerns-Aigle (IPHA)

Amparo Belloch (España), Héctor Fernández-Álvarez and
Claudia Castañeiras (Argentina).....183-195

Depression and marital discord.

Silvia Franchi (Argentina).....197-203

*Emotional Stroop: Assessment of cognitive biases
and Selective Information Processing in patients
with Anxiety disorders.*

Sergio Lo Tauro (Argentina).....205-224

Therapy's Metaphors.

Juan M. Molinari (Argentina).....225-231

*The interaction between psychotherapeutic interventions from
different theoretical frames and common factors in psychotherapies.*

Vanina Waizmann, Ignacio Etchebarne and
Andrés J. Roussos (Argentina).....233-244

Brief professionals' contributions to clinical practice.

An humanistic perspective in psychotherapy.

Patricia Cordella (Chile).....254-249

Psychotherapy today: Its situation in different countries.

Psychotherapy in Greece: From its origin to its recent advancements.

Vassiliki Pattakou-Parassiri and Argyroula E. Kalaitzaki (Grecia).....251-264

Interview

Mauricio Goldenberg (Argentina)

Lilían Corrado (Argentina).....265-274

Comments on current bibliography.....275-293

LA PSICOTERAPIA EN GRECIA: DESDE SUS ORÍGENES HASTA SUS AVANCES RECIENTES

Vassiliki Pattakou-Parassiri y Argyroula E. Kalaitzaki***

BUSCANDO EL ORIGEN DE LA PSICOTERAPIA GRIEGA

A través de una retrospectiva histórica, el cuadro de la evolución de la psicoterapia otorga relatividad a la "verdad científica", ya que es sólo una parte de la verdad completa en un proceso continuo por la conquista del conocimiento. Esto nos hace contemplar que cada era tiene su propia verdad científica y que los nuevos descubrimientos cambiarán en el futuro algunos aspectos de lo que hoy creemos correcto. Esta característica evolutiva es un desafío para la investigación futura, en tanto nos ayuda a evitar creencias dogmáticas que podrían tener efectos negativos sobre la sociedad, y también podrían inhibir el progreso de la ciencia. Hoy en día, la psicología es una ciencia, que está afiliada a las ciencias sociales o humanas, y su finalidad es investigar el comportamiento y sus causas. Sin embargo, inicialmente surgió como un esfuerzo por entender la naturaleza humana y por eso se vinculó a la filosofía.

La impresión de que la psicoterapia tiene su origen en la teoría freudiana, y que tiene un siglo de edad, no es completamente verdadera. La cultura griega - sin negar las contribuciones de otras civilizaciones- ha contribuido enormemente al desarrollo de la psicoterapia, incluso antes de la "era Clásica" del siglo V A.C. Muchos abordajes terapéuticos diferentes aplicados efectivamente al tratamiento de los trastornos mentales pueden rastrearse allí, extendiéndose desde la psicoterapia (a través del razonamiento dialéctico y rituales mágico-religiosos) hasta las terapias somáticas, como la dieta balanceada y la medicación (Hawkins y Nestoros, 1997). Antiguos filósofos y escritores médicos como Epicteto, Sócrates, Platón, Aristóteles, Epicuro, Heráclito, Hipócrates, Caelius Aurelianus, Celso, Galeno, etc., y escuelas de pensamiento tales como el Estoicismo, la escuela Epicúrea, el Eclecticismo y otras, tuvieron un gran impacto sobre nuestro pensamiento, y del mismo modo han influido en la psicología y psicoterapia como ciencias (Hawkins y Nestoros, 1997; Romilly, 1992). Desafortunadamente, la gran mayoría de los escritos de la antigüedad han desaparecido, debido a las numerosas destrucciones que ha sufrido Grecia. La destrucción de la mayoría de los escritos griegos antiguos ha sido elocuentemente ilustrada en la afirmación "la psicología moderna ha reinventado la rueda muchas veces" (Nestoros y Vallianatou, 1990/1996, p.38).

Más específicamente, la evolución de la Medicina Griega a través del tiempo fue seguida por la evolución de la psiquiatría y psicología. La historia de la Medicina puede dividirse en las siguientes eras (Tsouras, 1980):

- 1) La antigua Medicina Griega anterior a Hipócrates, 1440-500 A.C
- 2) La Medicina Hipocrática, 500-200 A.C.
- 3) La Medicina Greco-Romana, 200 A.C.-600 D.C.
- 4) La Medicina Bizantina (cronológicamente pertenece al período medieval).

*Vassiliki Pattakou-Parassiri: Social worker, Rh.D. candidate, University of Sunderland, U.K., Lecturer of Clinical Social Work, Social Work Department, School of Health and Social Welfare, Higher Technological Educational Institute of Crete, Heraklion, Crete, Greece. Tel.: 00 30 2810 379528. Fax: 00 30 2810 379504
Email: vpat@seyp.teiher.gr

**Argyroula E. Kalaitzaki: M.Sc., Ph.D. in Clinical Psychology, Assistant Professor of Psychology (temporary staff), Social Work Department, School of Health and Social Welfare, Higher Technological Educational Institute of Crete, Heraklion, Crete, Greece.
Revista Argentina de Clínica Psicológica XIII. p.p. 251-264.
© Fundación AIGLE.

Durante cada era, se aplicó un modelo terapéutico diferente para atender a las personas con trastornos psicológicos. Durante este período prevaleció el modo de pensamiento politeísta, y por lo tanto el pensamiento científico no existía. Las razones para todo se buscaban en los dioses, y las personas se sentían demasiado débiles para confrontarlos. (Tsouras, 1980). Las personas no podían pelear contra el poder de los dioses; preferían tratar de aliviar su rabia con oración y súplica. Durante esta era, las personas se dirigían a los desórdenes psicológicos con temor reverente, cuidado y respeto, y por lo tanto se distribuía la terapia en lugares asociados con los dioses y la religión (Ierodiakonou, Fotiadis y Dimitriou, 1988).

En la Antigua Grecia, había aproximadamente 320 templos tanto de alabanza como de terapia. Los más famosos fueron los de Epidauros, Trikis y Kos. Los templos de Asclepio se utilizaban como refugios para las personas que sufrían de todo tipo de trastornos, especialmente aquellos con trastornos mentales (como histeria). La terapia incluía, entre la psicoterapia y farmacoterapia convencionales, dietas especiales, ejercicio físico, terapia ocupacional, musicoterapia, danzoterapia, conferencias y talleres sobre historia, literatura y filosofía griegas, etc. Se diseñaban dietas especiales para influir en las funciones mentales y corporales, de acuerdo con los hallazgos neurocientíficos más recientes sobre la etiología de los trastornos mentales. Se esperaba que los ejercicios físicos mejoraran una variedad de condiciones psicológicas, según el dictamen "*mente sana en cuerpo sano*" (Hawkins, 2000; Nestoros, 2000). Este procedimiento tenía una característica ritualística; se les ofrecía expectativas positivas y se acrecentaba su fe en los resultados positivos de la terapia. El paso final en la terapia era "dormir en el templo" (ενκοίμησις: enkoimisis). Los templos utilizados para fines terapéuticos siempre estaban específicamente estructurados. El ambiente era higiénico, pacífico y tranquilo. Había áreas gimnásticas y a veces se tocaba música apropiada, específica para enfermedades particulares. Los hombres y mujeres estaban separados. Enkoimisis (i.e. dormir en el templo) tenía un lugar central en el proceso psicoterapéutico (i.e., probablemente era una forma de hipnosis clínica; Aravantinos, 1907; Hawkins y Nestoros, 1997; Kouretas, 1960).

Desde los escritos de Platón (Timeo de Platón, I) aprendimos que "familiarizar a un joven con la vida, la muerte y las funciones de la naturaleza era un ritual social de iniciación y desmitificación del mundo" (Nestoros, Vasdekis, Pattakou y Sfakianakis, 1998). Este proceso terapéutico ayudaba a las personas a escapar del trastorno psicológico y a ahuyentar al miedo (Nestoros, et al., 1998).

Melampous fue el médico mitológico más prominente; fue el primer psicofarmacólogo, psicoterapeuta, médico y vidente/pronosticador (las técnicas terapéuticas básicas que utilizaba eran la medicación y la expiación). Se dice que Amphiaraos era el nieto de Melampous, y que él también fue médico y vidente/pronosticador. El "Amphiarion" se construyó durante los años clásicos (siglo V A.C.), y era tanto un templo como una clínica para el tratamiento de los trastornos mentales; fue uno de los primeros -si no el primer- centro comunitario de salud mental, donde se aplicaba musicoterapia en grupos (Papadatos & Stogianidou, 1998).

Durante el período Hipocrático (460-377 A.C.) las ideas dominantes fueron las de Hipócrates. Hipócrates creía que las enfermedades psicológicas, las así llamadas "frenitides" se debían a otras causas distintas a los poderes sobrenaturales, y por lo tanto, reclamaba a las personas mentalmente enfermas desde los Templos de Asclepio (Ierodiakonou, 1998).

Sócrates (durante la era posterior a Hipócrates) es considerado el padre de la psicoterapia. Fue el primero en practicar el método obstétrico, que es el método que conduce al interlocutor a conclusiones lógicas para resolver sus problemas. Este abordaje podría considerarse como uno de los mejores que la psicoterapia tiene para ofrecer, ya que este proceso convence a los pacientes que ellos tienen dentro de sí mismos la potencialidad para encontrar la solución a sus problemas

(Nestoros y Vallianatou, 1990/1996).

El período Helénico-Romano finaliza con Galeno (130-200 D.C.), quien enfatizó la importancia de los factores psicológicos en la aparición de las enfermedades psicosomáticas. Hoy en día, es considerado el que introdujo el aspecto psicosomático en la psiquiatría (Ierdiakonou, 1988). Prestó mucha atención al sistema nervioso central y creía que el cerebro era la base de todas las funciones psicológicas. Sugirió que la salud mental depende del balance entre las tres funciones del cerebro: la lógica, la irracional y la sensorial (Hartokolis, 1986).

El período Bizantino coincide con la edad media en Europa. Las ideas medievales arribaron tarde a Bizancio. El interés de los médicos por los trastornos psicológicos y las ideas de Hipócrates y Galeno eran aún fuertes y dominantes. Aproximadamente durante el siglo XI, la sociedad estaba preocupada por la demonología. Por lo tanto, las personas creían que los demonios perturbaban la función del alma, y entonces las perturbaciones psicológicas y las enfermedades mentales se atendían con hechizos. Incluso los sacerdotes utilizaban exorcismos para atender los trastornos psicológicos de las personas. Estas supersticiones dominaron el mundo Cristiano entero y resultó en la abolición de cualquier alegato psicoterapéutico (Ierodiakonou, 1988). Aunque se ha progresado marcadamente, desafortunadamente estas ideas prevalecen hoy en día.

Durante el mismo período un hombre muy famoso llamado Asklipiades fue el primero en diferenciar los estados agudos y crónicos de los trastornos psicológicos, y las psicosis funcionales de los trastornos fisiológicos. Atendió especialmente pacientes mentalmente enfermos e intentó calmarlos utilizando varios dispositivos, algunos tipos de baños y música relajante.

LA EVOLUCIÓN DE LA PSICOTERAPIA Y AVANCES RECIENTES

Un breve informe histórico

El desarrollo de la psicoterapia en Grecia no fue un proceso fácil. Las teorías freudianas fueron en principio consideradas con mucha cautela y escepticismo. Cuando se le pidió al Profesor Kouretas que diera una conferencia sobre psicoanálisis en la Asociación Médica de Tesalónica, en 1927, se le negó el acceso a este foro y finalmente dio su conferencia en el bar local de la Asociación. Esto ocurrió porque un miembro de la Junta de la Asociación Médica que había estudiado en Viena y asistido a algunas conferencias de Freud, expresó su punto de vista que el psicoanálisis "está contra los estándares morales virtuosos de los griegos", un "miasma", y más aún, que causa "corrupción psíquica" (Kouretas, 1984; Nestoros, 1998). Luego, la psicoterapia en Grecia siguió un lento desarrollo. La teoría freudiana careció de progreso significativo durante este período. El primer grupo psicoanalítico se fundó en 1946, y fue abolido en 1950, para ser fundado nuevamente en la década del 60 (Kouretas, 1984). Inversamente, la teoría de Adler tuvo un relativo progreso, como puede verse en la fundación de una asociación emparentada en Atenas (1931-1932) (Ploumpidis, 1984).

El interés por la psicoterapia ha crecido dramáticamente en los últimos 10 años y apareció un desarrollo considerable, teniendo en cuenta a) el número existente de psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas y otros profesionales de la salud mental griegos b) la formulación de un movimiento claro de integración en psicoterapia, c) el establecimiento de cuatro Departamentos de Psicología, d) el número de institutos psicoterapéuticos privados fundados en Grecia, y e) el establecimiento de organizaciones profesionales.

La psicoterapia evolucionó rápidamente luego del establecimiento del primer Departamento de psicología en Grecia, que se fundó en la Universidad de Creta en 1987. Luego de eso, se establecieron tres Departamentos más (el Departamento de Psicología de Panteion University, en la Universidad de Atenas, y en la Universidad Aristotélica de Tesalónica). El Departamento de

Psicología de Creta ha crecido rápidamente en los últimos años cubriendo la mayoría de los aspectos y disciplinas de la Psicología en programas de enseñanza e investigación.

Simultáneamente con el establecimiento de los departamentos de psicología, comenzaron a surgir los primeros institutos privados de entrenamiento en psicoterapia. Hoy en día muchos institutos privados se han fundado en Grecia para cubrir la necesidad de entrenamiento en psicoterapia. Aproximadamente 150 institutos se ubican en la capital de Atenas, alrededor de 50 en Tesalónica, que es la segunda gran ciudad en Grecia en términos de su población, y alrededor de 65 en otras partes de Grecia.

Hoy en día en Grecia hay muchos psiquiatras, psicólogos y psicoterapeutas. Las cuatro tendencias prominentes en psicoterapia son la escuela psicodinámica, la escuela comportamental, la escuela humanístico-existencial y la teoría sistémica. Además la propuesta de Psicoterapia Synthetiki (psicoterapia integrativa), de la palabra griega *síntesis*, ha formulado recientemente un claro movimiento en el campo de la psicoterapia en Grecia. El abordaje griego de integración en psicoterapia fue desarrollado por el profesor J.N. Nestoros (Profesor de psicología clínica del Departamento de Psicología, Universidad de Creta), y fue inicialmente publicado en griego en su libro titulado "Synthetiki psychotherapia" (Nestoros y Vallianatou, 1990/1996), mientras que en 1993 publicó el libro titulado "Ston kosmo tis psychosis" (En el mundo de la psicosis) en el que demuestra la psicoterapia integrativa con pacientes psicóticos. En 1997 el modelo fue publicado por primera vez en inglés (Hawkins y Nestoros, 1997, Nestoros, 1997a,b; Nestoros, Lampropoulos et al., 1997). El marco teórico y los principios de la Psicoterapia Synthetiki para entender la naturaleza humana, la personalidad, la psicopatología y la psicoterapia, junto con sus aplicaciones en pacientes psicóticos, han sido ampliamente publicados en varios lugares. (e.g., Nestoros, 1993, 1997, 1998, 2001).

Aquellos que practican la psicoterapia derivan básicamente de alguna de las siguientes áreas científicas (Fatourou-Haritou, 2000):

- 1) Psicólogos que se han especializado en psicología clínica. Podrían ser empleados en cualquier tipo de servicios de salud psicológica.
- 2) Psiquiatras; trabajan con el amplio espectro de los trastornos psicopatológicos y son los únicos que prescriben medicación. Trabajan en todos los sectores de los servicios de salud mental, incluyendo el psicológico, y están, casi siempre, en una jerarquía más alta y su práctica incluye más responsabilidades que la de los psicólogos clínicos. Psiquiatras especializados trabajan con niños y adolescentes.
- 3) Trabajadores sociales psiquiátricos; trabajan en todas las áreas de los servicios de salud psicológica y practican trabajo social y psicoterapia con individuos y grupos.
- 4) Enfermeras psiquiátricas; usualmente desempeñan trabajo suplementario en hospitales y clínicas psiquiátricas.
- 5) Los psicoanalistas son principalmente psiquiatras, pero también psicólogos, trabajadores sociales o incluso sacerdotes. Se entrenan en institutos psicoanalíticos reconocidos más que en universidades.
- 6) Consultores de parejas son comúnmente empleados en centros de counselling y se abocan a los problemas en las relaciones y en la comunicación, así como a la violencia familiar. Pueden tener un grado básico en cualquiera de las especialidades antes mencionadas.
- 7) Otro tipo de terapeutas ofrecen trabajo terapéutico auxiliar, tal como musicoterapia, danzoterapia, terapia ocupacional, etc. Pueden provenir de cualquiera de las especialidades anteriormente mencionadas y trabajan en lugares similares.

La definición de psicoterapia

A pesar de la reciente proliferación de la psicoterapia, no existe una definición ampliamente acep-

tada e
ciones
En el li
psicote
un proc
se desi
interve
versaci

De acu
método
rapeuta
ducir la

Manos
cológic
con el
peuta
el proc
remisi
ej. psi
interpe

Una re
temáti
tan pr
portar

Según
proce
un mo
el log
es de

Entre
En G
privat
reque
durac
tigad
revisi
institi
ción
la ori
entre
instit
se to
dos
prov
gular

tada entre los profesionales de la salud mental. A continuación el lector podrá encontrar definiciones indicativas que han sido propuestas por los psicoterapeutas más prominentes de Grecia. En el libro de Hartocollis (1986) titulado 'Introducción a la psicoterapia', se ofrece una definición de psicoterapia en términos de su etimología, "terapia del alma". Más específicamente, se refiere a un proceso terapéutico que utiliza canales psicológicos, en una relación terapeuta-paciente, que se desarrolla a través del diálogo. Paraskevopoulos (1988) define la psicoterapia como sigue: "la intervención psicológica es mencionada como *psicoterapia*, y usualmente se la sugiere en conversaciones con el paciente y en la guía metódica y cambio del comportamiento del paciente".

De acuerdo al Diccionario griego de psicología (Papadopoulos, 1994), la psicoterapia incluye métodos de intervención basados en los procedimientos psicológicos y en el acuerdo paciente-terapeuta sobre el modo de comunicación. El objetivo final de estos métodos sistemáticos es producir la eliminación sintomática que causa infelicidad o perturba las relaciones interpersonales.

Manos (1997) se refiere a la "psicoterapia como una forma de terapia para los trastornos psicológicos". Durante la psicoterapia una persona entrenada establece un acuerdo de cooperación con el paciente, y a través de una comunicación terapéutica determinada - verbal o no- el terapeuta intenta producir un alivio sintomático, cambio de comportamientos desadaptativos, y alienta el proceso de desarrollo personal del paciente. Una psicoterapia efectiva, ya sea basada en la remisión sintomática (por ej. terapia comportamental), o en el desarrollo de la personalidad (por ej. psicoanálisis), se refleja básicamente en el logro alcanzado por el paciente en sus relaciones interpersonales, en el trabajo (ambiente laboral), y en el sabio uso de su tiempo libre.

Una reciente edición en psicoterapia define el proceso psicoterapéutico como una interacción sistemática entre un especialista, autorizado por la sociedad, y una o más personas que experimentan problemas psicológicos. El objetivo de la psicoterapia es el cambio cognitivo, emocional o comportamental con el fin de eliminar los problemas psicológicos (Fatourou-Haritou, 2000).

Según Hawkins y Nestoros (1997) hoy la psicoterapia se entiende generalmente no sólo como un procedimiento aplicado para reducir la incomodidad y el sufrimiento en la vida sino también como un modo de mejorar la calidad de vida. En terminología Epicúrea, el objetivo de la psicoterapia es el logro de placer de la vida ('ἡδὼς ζῆν *ideos zin*). En este sentido cuanto más saludable uno es desde el punto de vista psicológico, más puede beneficiarse de la psicoterapia".

Entrenamiento en psicoterapia

En Grecia, el entrenamiento en psicoterapia está principalmente proporcionado por instituciones privadas, que predominantemente, no reúnen los prerequisites mínimos y estándares altos requeridos para el entrenamiento en psicoterapia (por ej. Calificación de los entrenadores, duración del entrenamiento). El entrenamiento disponible para la psicoterapia en Grecia fue investigado hace pocos años (Kalaitzaki, 1995). El estudio involucró dos fuentes de información: a) una revisión del material impreso (por ej. prospectos) relacionado con cursos de psicoterapia de varias instituciones griegas de entrenamiento, y b) un cuestionario, con el propósito de extraer información detallada sobre los objetivos, contenidos y duración de los cursos, acuerdos de supervisión, la orientación del curso, requerimientos de los estudiantes, y criterios de selección de quienes se entrenan y de quienes los entrenan, etc. Los 94 ítems del cuestionario fueron enviados a todas las instituciones localizadas en Grecia; y hubo muy poca respuesta (22 instituciones). En estos casos, se tomaron en consideración y se examinaron la folletería y las hojas de respuesta. Los resultados derivan tanto del cuestionario como de la investigación del material impreso. La información proveniente de la folletería y de las hojas de respuesta diferían ampliamente entre sí, siendo irregular en varias instancias.

Veintiuna de las veintidós instituciones localizadas en Atenas eran privadas, y sólo cinco de ellas eran ramas de Institutos Europeos o Internacionales o al menos mantenían una vinculación con ellos. Todas las instituciones se establecieron para cubrir tanto las necesidades contemporáneas didácticas como clínicas de la psicoterapia de adultos y de niños. El entrenamiento en poblaciones específicas no era cubierto como rutina en estos cursos; aún cuando se indicaba que en tal curso de entrenamiento se abordaban ciertos aspectos particulares, era imposible hacer cualquier referencia acerca de la profundidad o calidad de lo que cubrían. Solamente una pequeña proporción de los entrenamientos en psicoterapia enseñaba tópicos específicos en psicopatología y el tratamiento farmacológico apropiado, lo que es muy preocupante. Esto incluye a algunos de los cursos de entrenamiento más respetables. Mas aún, una minoría de los cursos ofrece entrenamiento en tópicos tales como ética profesional, objetivos y organización de los sistemas de salud psicológica y bienestar. Una pequeña minoría enseñaba cómo estructurarse en la práctica privada, mientras que un porcentaje mayor pero aún insuficiente incluía al menos algunas enseñanzas sobre temas de salud y empleo.

La mayoría de los cursos de entrenamiento (87,5%) se encargan de un vasto rango de responsabilidades, tales como terapia y entrenamiento, organización de seminarios y supervisión. Muchos de ellos ofrecen posibilidades de investigar (75%), facilidades de laboratorio (25%), y organizan congresos (75%), aparte del entrenamiento en psicoterapia. Ninguno de los cursos de entrenamiento tiene a la práctica clínica y la supervisión como una parte integrada del curso. La responsabilidad y la organización de la supervisión varía significativamente. La mayoría de los cursos de entrenamiento declaran que se encargan de alguna supervisión, mientras que los cursos restantes no requieren que sus estudiantes practiquen psicoterapia bajo supervisión regular como parte del entrenamiento. Solamente un curso requería la psicoterapia personal como central para el desarrollo personal y profesional de sus estudiantes. También la duración del entrenamiento variaba ampliamente entre pocos meses hasta 5 años. ($m=2,00$ años, $s.d.=1,85$).

Se ofrece un amplio rango de cursos de una variedad de modelos psicoterapéuticos y modalidades. La mitad de los cursos de entrenamiento aplican sólo un modelo de tratamiento en su práctica clínica (por ej. Psicoanálisis, psicodrama, psicoterapia por el arte, etc.), mientras que el resto ofrece más de una modalidad psicoterapéutica o la combinación de algunas de ellas. En general, cada vez más institutos de entrenamiento combinan más de un abordaje psicoterapéutico tanto en su entrenamiento como en su práctica clínica.

La calificación y los estándares tanto de los estudiantes como de los docentes mostraron una considerable disparidad. Tampoco los cursos fueron claros en cuanto a los estándares y los grados académicos, y aparentemente diferían en sus estándares. Más específicamente, todo tipo de profesionales (ej. abogados, docentes) además de los profesionales en salud mental (ej. psicólogos, psiquiatras) eran aceptados para recibir entrenamiento en psicoterapia. Asimismo, no había un mínimo de requerimientos o cualidades para la selección de los supervisores y entrenadores.

El estudio anteriormente mencionado proveyó de resultados desfavorables en consideración con el entrenamiento en psicoterapia en Grecia. Sorprendentemente, el entrenamiento en psicoterapia no ha aumentado, o al menos no ha aumentado considerablemente, en los años recientes. Hay muchas personas entrenadas inadecuadamente, y el desarrollo en entrenamiento en psicoterapia ha sido tan rápido, perdiendo en profundidad y calidad. De modo similar, se dio a conocer que la expansión de los psicoterapeutas autoproclamados no se emparenta con un alto estándar de entrenamiento en psicoterapia. La falta de licencia profesional y acreditaciones que legalicen la Certificación de la psicoterapia, y de una legislación relevante que incluya la calificación de los entrenadores, altos estándares para los cursos, etc., acentúan el problema y producen confusión en el campo.

Excluyendo los institutos privados, que principalmente ofrecen entrenamiento cuya calidad es discutible, en Grecia existen dos posibles alternativas que contribuyen significativamente en el entrenamiento de nuevos psicoterapeutas: a) Programas de entrenamiento de posgraduación universitarios y b) Instituto Europeo de Psicoterapia (European Institute of Psychotherapy), U.K., que otorga el Diploma Europeo en las Terapias Psicológicas.

Supervisión de la Psicoterapia

La supervisión en psicoterapia es un procedimiento complejo tanto para el supervisor como para el supervisado, y es de primordial importancia. (Kalaitzaki, 1995; Nestoros, 1997a). La mayoría de las habilidades de un buen terapeuta no se obtienen a través de la investigación, pero sí a través del "desarrollo personal", y a través de realizar psicoterapia bajo una buena supervisión (Nestoros, 1997a; Nestoros, Kalaitzaki, y Zgantzouri, 1999). Una supervisión de calidad puede mejorar la enseñanza y el aprendizaje de habilidades terapéuticas y promover satisfacción en los supervisados. Martin y Schinke (1998) corroboraron que una cantidad de elogios por parte del supervisor influencia la satisfacción en el trabajo y los niveles de burnout. Reid et al (1999) refieren que la supervisión también constituye la fuente formal principal de apoyo para muchos profesionales.

El entrenamiento en psicoterapia es un proceso en el que el estudiante tiene que desarrollar no sólo sus habilidades y aptitudes sino también elaborar su teoría y técnicas, pero que le sirvan como herramientas para la expansión de sus recursos personales y para la promoción de su crecimiento, maduración y conocimiento (Chung, 1990). Otras características del terapeuta, obtenidas o desarrolladas y alentadas por el entrenamiento y la supervisión, son el coraje, que fortifica al terapeuta contra el dolor del paciente y del terapeuta, la imaginación y la curiosidad, que son factores importantes para el desarrollo personal y profesional del psicoterapeuta (Nestoros, Kalaitzaki y Zgantzouri, 1999). También, estudios durante los años 1950 dan apoyo a la evidencia de que los resultados positivos de la psicoterapia dependen más de la experiencia del psicoterapeuta y de las características de su personalidad que de su abordaje teórico (Nestoros, 1997b). Es evidente que el entrenamiento y la supervisión del psicoterapeuta son tópicos muy significativos y críticos a los cuales hay que prestar atención.

Investigación en psicoterapia

Recientemente, había muy pocos estudios de investigación en relación a la psicoterapia conducidos y publicados en Grecia. Platrites (1995) encontró que tanto los congresos de psiquiatría como de psicología contenían un porcentaje bajo de estudios sobre psicoterapia, comparado con otros tópicos. El pequeño número de terapeutas bien entrenados, calificados y el insuficiente entrenamiento en métodos de investigación y diseño son dos factores básicos que influyen en la cantidad y calidad de la investigación realizada.

No obstante, en la última década hay un aumento de la cantidad de publicaciones por año (por ej. 22 publicaciones fueron realizadas en 1989, 42 en 1991, y 49 en 1994). Todas ellas en inglés y conducidas principalmente por instituciones universitarias o instituciones afiliadas a universidades. En el Laboratorio de Psicología Clínica y Social, Departamento de Psicología, Universidad de Creta, hay un interés creciente en la investigación relacionada con la efectividad de la psicoterapia integrativa. Se están llevando a cabo y presentando varios proyectos en distintos encuentros científicos nacionales, europeos e internacionales desde 1995. Los resultados de estos estudios también son publicados en revistas científicas y como capítulos de libros. El equipo de investigación también colabora y está vinculado con otros laboratorios universitarios y departamentos, disciplinas de la ciencia social, unidades de cuidados de la salud, institutos y otras instituciones griegas y extranjeras, y consecuentemente ha brindado oportunidades para unir la investigación con áreas relevantes de interés común.

No obstante, la investigación en Grecia en general no ha tenido el rápido crecimiento de la psi-

coterapia en el mundo, el cual ha derivado en el reconocimiento de ciertos campos concretos de investigación que ahora reclaman ser reconocidos como departamentos especiales de psicología, o hasta ciencias por derecho propio. Existe una necesidad de investigación progresiva con estándares altos en psicoterapia en Grecia, lo cual promocionaría tanto la clarificación teórica como la validación empírica de teorías y terapias, así como avanzar en nuestra comprensión sobre cómo funciona la psicoterapia y cómo cambian las personas.

Legislación

A pesar de que las organizaciones psicológicas en Grecia han contribuido significativamente para el progreso de la profesión de la psicología, no ha habido un crecimiento similar en el campo de la psicoterapia. La psicoterapia en Grecia no está acreditada. En relación a las actividades y los servicios de salud, nadie puede declararse como psicoterapeuta sin la autorización para practicar la profesión. No obstante, la ausencia de una certificación de la psicoterapia oficialmente aceptada produce anarquía en el campo. La inclusión casi automática de psiquiatras, psicólogos, y otros profesionales de la salud mental en un listado de psicoterapeutas es engañoso e injusto, dado que raramente ellos tienen un entrenamiento apropiado. Se estima que aproximadamente el 30% de los psicoterapeutas son psicólogos autorizados, los restantes, por ejemplo, doctores autorizados, trabajadores sociales, sacerdotes y enfermeras autorizadas. La falta de una legislación relevante también permite que los institutos de entrenamiento tengan criterios indefinidos de selección para sus estudiantes. Esto produce un círculo vicioso, cuya perpetuación necesita ser eventualmente interrumpida. Frente al aumento de practicantes que se llaman a sí mismos "psicoterapeutas", es necesario establecer una legislación relevante. La psicoterapia debería ser una especialización posterior al título académico de grado en profesionales en salud mental.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Esperamos que este trabajo haya brindado un claro panorama del estado del arte del campo de la psicoterapia en Grecia. Es claro que la psicoterapia en Grecia ha recorrido un largo camino desde sus tempranos inicios, y que a lo largo de las últimas dos décadas ha habido un acelerado desarrollo, evidente en el número de terapeutas disponibles y también en el entrenamiento en psicoterapia. Recientes tendencias, como la iniciativa del instituto nacional de salud, ha puesto el foco en la importancia de identificar las cualidades de aquellos que brindan servicios de salud mental (Beutler y Kendall, 1995). Sin embargo, la mayoría de los psicoterapeutas en Grecia están entrenados por instituciones privadas y consecuentemente, sus calificaciones están generalmente por debajo de los estándares necesarios para la acreditación. Por el contrario, hay un escaso incremento de psicoterapeutas bien calificados por programas de posgrado. La impresión general es que los entrenamientos privados en terapias psicológicas (ofrecidas por los institutos) están más orientadas hacia un mercado dominado por los deseos de los dueños de dichos institutos, y que la currícula del entrenamiento no refleja las necesidades de salud mental ni de la población en general ni las de los profesionales que se entrenan.

A pesar de las buenas intenciones de los tutores, parece difícil realmente entrenar en psicoterapia de acuerdo a los estándares requeridos por los lineamientos establecidos universalmente. Las investigaciones publicadas sobre entrenamiento en psicoterapia para psicólogos y psiquiatras (e.g. Hwang & Drummond, 1996; Hamilton & Tracy, 1996; McCrindle, et al, 2001) muestran repetidamente que el entrenamiento no completa los requerimientos y los estándares. Los estudios usualmente indican extensas desventajas e imperfecciones en su distribución, tales como falta de oportunidades para tomar casos y déficit en la enseñanza didáctica. Por lo tanto, para evitar la escasez de psicoterapeutas bien calificados, y por ende también de entrenadores, esta situación debe ser atendida. Esto requiere de entrenadores competentes, y el diseño apropiado de una currícula de entrenamiento. Por esta razón, nosotros deberíamos enfatizar la importancia de una elevada calidad del entrenamiento en psicoterapia, que puede lograrse a través del establecimiento de los

estándares aceptados universalmente por organizaciones internacionales tales como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

No es el objetivo de este trabajo hacer recomendaciones para mejorar el entrenamiento en psicoterapia. No obstante, debería subrayarse la necesidad de un cuerpo de conocimiento abarcativo, que focalice en la enseñanza de habilidades en la formulación de los casos, y que enfatice la supervisión y el desarrollo personal. Más aún, el ampliar el rango de modalidades a entrenar, junto con el brindar conocimiento y técnicas específicas para ciertos trastornos, es de suma importancia. También se debería tomar en cuenta la necesidad de desarrollar medidas estándares de competencia.

A pesar de que la supervisión fomenta el conocimiento y la sensibilidad entre los psicoterapeutas, es un dominio de la práctica profesional para el cual el entrenamiento y los estándares formales han sido descuidados por mucho tiempo. Se propone la supervisión individual y/o en grupos pequeños como área central de competencia en los cursos de entrenamiento para lo cual deben tenerse en cuenta una serie de elementos que reflejen conocimiento específico, habilidades y valores para garantizar un adecuado entrenamiento y el desarrollo profesional de quienes lo realizan. Ciertamente, es necesaria la selección de supervisores y tutores experimentados para conseguir las tareas antes mencionadas.

El desarrollo personal también es una característica importante de la personalidad y de las competencias del terapeuta. El interjuego entre terapeuta-paciente crea un espacio para que el crecimiento y la curación puedan ocurrir, como fue mencionado por Weinstein (1998). Macran y Shapiro (1998) sostienen que la mayoría de los terapeutas sienten que su terapia personal los ha beneficiado profesionalmente, dado que tiene un efecto positivo en aquellas características del terapeuta que son consideradas esenciales para promover cambios en los pacientes (por ej. empatía, calidez, autenticidad). El psicoterapeuta puede cambiar como resultado del trabajo con un determinado paciente (Kahn, Harkavy-Friedman, 1997). Por otro lado, las demandas únicas (stress y burnout) que tienen los profesionales de la salud mental y quienes se entrenan en psicoterapia son enormes. Los psicoterapeutas también se pueden encontrar con varias situaciones que vivan como difíciles y con las cuales tengan que lidiar (Davis, Elliott, Davis, Binns, Francis, Kelman y Schroder, 1987). Por lo tanto, es esencial que los terapeutas trabajen sobre sus propias dificultades, que surgen en el curso de una terapia, para ayudar más efectivamente a los pacientes. El trabajo de supervisión personal les facilita absorber tanto los impactos negativos como los positivos que la práctica de la psicoterapia puede producir en su personalidad, en sus recursos internos y en sus habilidades y capacidades profesionales.

Grecia se ha convertido actualmente en un país con gran diversidad cultural, y por esto ha surgido la necesidad de brindar una diversificación de intervenciones. Para responder a las necesidades de poblaciones de pacientes diferentes, los psicoterapeutas deben adaptar los tratamientos para que reflejen la sensibilidad y respeto por la diversidad cultural, y adquirir habilidades y capacidades para trabajar con grupos étnicos diferentes. Los profesionales de la salud mental también tienen necesidad de incorporar en la planificación de los tratamientos y en sus intervenciones en la práctica, estrategias basadas en la cultura y validar las fortalezas de los pacientes. El desarrollo de un conjunto de conductas, actitudes y políticas congruentes les ayudará a ser competentes a la hora de brindar servicios de salud mental efectivos y de elevada calidad en diversas situaciones transculturales. El conocimiento sobre la diversidad étnica también debería incorporarse en los programas de entrenamiento.

También deberían incorporarse inevitablemente a la currícula de entrenamiento en psicoterapia y a su práctica las tendencias recientes (e.g. telesalud). Telesalud es definida como "el uso de las telecomunicaciones y la información tecnológica para brindar acceso a la evaluación de la salud,

diagnóstico, intervención, consulta, supervisión, educación e información a distancia." (Nickelson, 1998, p. 527). La tecnología provee psicoterapia con oportunidades no esperadas y rápidamente reformula y expande la distribución de servicios de salud mental, lo cual requiere, por supuesto, de un entrenamiento altamente calificado.

Es indiscutible el progreso de la investigación sobre psicoterapia en la última década en el mundo. La literatura se ha enriquecido con los hallazgos sobre los resultados de la psicoterapia, los factores comunes, combinación de farmacoterapia y psicoterapia, técnicas de tratamiento y lineamientos prácticos, terapias breves, etc. Sin embargo, la investigación empírica ha influenciado al entrenamiento y a la práctica clínica sólo de un modo limitado. El conocimiento basado en la investigación es importante para la práctica clínica. Por ejemplo, los psicoterapeutas necesitan del conocimiento basado en la investigación para poder informar a sus pacientes acerca de los posibles tratamientos, monitorear los tratamientos y los resultados, y reconocer las posibilidades y deseos de los pacientes para involucrarse en la terapia. La práctica de la psicoterapia basada en la evidencia implica un continuo intercambio de información entre los investigadores, clínicos, proveedores de servicios, y consumidores (por ej. pacientes, familiares). Esta integración entre la investigación y la práctica ha sido sostenidamente propuesta y discutida (Lampropoulos, Goldfried, Castonguay, Lambert, Stiles y Nestoros, 2002; Lampropoulos y Spengler, 2002; Spengler, Strohmer, Dixon, y Shivy, 1995). El psicoterapeuta necesita conducir en su práctica de investigación aspectos que sean relevantes para la práctica clínica, y también utilizar la literatura existente y la gran cantidad de otras evidencias empíricas derivadas de la investigación clínica en el diseño y aplicación de técnicas y estrategias apropiadas para su práctica clínica (Goldfried, Borkovec, Clarkin, Johnson y Parry, 1999; Strupp, 1989). El psicoterapeuta necesita ser tanto un aplicado científico como un profesional clínico.

Para lograr una psicoterapia más eficiente se requiere de una mayor integración de los resultados de las recientes décadas con la práctica terapéutica más efectiva de las diversas disciplinas. Por ejemplo, incorporar los hallazgos actuales de la neuropsicología y la psicología y el apropiado entrenamiento en habilidades que permita a los psicoterapeutas producir los resultados de tratamientos más efectivos.

Para recapitular, los profesionales de la salud mental necesitan entrenamientos sólidos y calificados en psicoterapia para servir mejor a sus pacientes y para mantener la competencia en el mercado de la salud mental. Los programas de entrenamiento existentes carecen de un abordaje sistemático e integrado, que sea simultáneamente basado en la clínica y en la investigación (Beitman y Yue, en prensa). Tanto el mercado actual como la industrialización del cuidado de la salud necesitan desafiar a la comunidad de entrenamiento a los fines de responder a dichas demandas. Los cursos de entrenamiento necesitan incluir desarrollo de habilidades, desarrollo personal y práctica clínica así como la comprensión de la teoría, para alcanzar una colaboración entre la ciencia y la práctica. Se enfatiza la necesidad de establecer programas de alta calidad de entrenamiento de posgrado y doctorados en clínica psicológica y en psicoterapia, no dirigidos enteramente a la investigación, pero también persiguiendo una carrera exitosa. Dado que es irreal asumir que los programas de entrenamiento siempre cumplirán con los estándares necesarios para un entrenamiento de alta calidad, debería legislarse sobre este punto. Todos los cursos de entrenamiento deberían incluir un proceso detallado para la acreditación, que posibilitará y garantizará la calidad del entrenamiento (por ej. entrenamiento de psicoterapeutas con los estándares profesionales más altos).

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Beitman, B.D., y Yue, D. (en prensa). A time-efficient, research-based, outcomes-measured psychotherapy training program. *Academic Psychiatry*.
- Beutler, L.E., y Kendall, P.C. (1995). Introduction to the special section: the case for training in the provision of psychological therapy, *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 63, 179-181.
- Chung, C.Y. (1990). Psychotherapist and expansion of awareness. *Psychotherapy y Psychosomatics*, 53, 28-32.
- Davis, J.D., Elliott, R., Davis, M.L., Binns, M., Francis, V.M., Kelman, J.E., y Schroder, T.A. (1987). Development of a taxonomy of therapist difficulties: initial report. *British Journal of Medical Psychology*, 60, 109-119.
- de Romilly J. (1992). *Vasta Kardia mou: I anaptiksi tis psychologias sta archaia Ellinika grammata* (Endure, my Heart: The development of psychology in the ancient Greek letters), translation from the French 1991 Societe d' Edition Les Belles Lettres by Athanasiou B., Athens: Asty Editions,
- Fatourou-Haritou, M. (2000). Psychotherapeutiki praktiki (Psychotherapeutic practice. En M. Nasiakou, A. Xantzi, y M. Fatourou-Haritou (Ed.), *Eisagogi stin Psycholohia* (Introduction in Psychology), Athens: Gutenberg.
- Goldfried, M.R., Borkovec, T.D., Clarkin, J.F., Johnson, L.D., y Parry, G. (1999). Toward the development of a clinically useful approach to psychotherapy research, *JCLP/In Session: Psychotherapy in Practice*, 55, 1385-1405.
- Hamilton, R.J. y Tracy, D. (1996). A survey of psychotherapy training among psychiatric trainees. *Psychiatric Bulletin*, 20, 536-537.
- Hawkins, P.J. (2000). *Eisagogi stin Cliniki ipnosi*, (Introduction in Clinical Hypnosis). Athens: Ellinika Grammata. En P.J Hawkins y M. Heap, (eds.), *Hypnosis in Europe* (pp. 99-117). London: Whurr Publishers Ltd.
- Hawkins, P.J., y Nestoros, J.N. (Eds) (1997). Beyond the dogmas of conventional psychotherapy: The integration movement. En P.J. Hawkins y J.N. Nestoros (Eds), *Psychotherapy: New perspectives on theory, practice and research* (pp. 23-95). Athens: Ellinika Grammata.
- Hwang, K.S. y Drummond, L.M. (1996). Psychotherapy training and experience of successful candidates in MRCPsych examinations. *Psychiatric Bulletin*, 20, 604-606.
- Ierodiakonou, X., Fotiadou, X., y Dimitriou, E. (1988). *Psychiatriki (Psychiatry)*. Thessaloniki: Mastoridis.
- Kahn, W.L., Harkavy-Friedman, J.M. (1997). Change in the therapist: the role of patient-induced inspiration. *American Journal of Psychotherapy*, 51, 403-14.
- Kalaitzaki, A.E. (1995, July). The training of psychotherapists in Greece. *IV European Congress of Psychology*. Athens, Proceedings; S-THR.06.4, p. 569-570.
- Kouretas, D. (1960). *Neotropoi ekfanseis ton psychotherapevtikon methodon aitines efirmozonto eis ta iera temeni tis archaias Ellados*. Parnassos, Vol. B, No 4.

- Kouretas, D. (1984). Anaminiseis dia tin psychanalsi eis tin Ellada (Recollections on psychoanalysis). In Th. Tzavaras (ed.) *Psixanalisi kai Ellada: Stoixeia, theseis, erotimata (Psychoanalysis and Greece: Elements, aspects, questions)* (pp. 35-39). Athens: Zaxaropoulos-Athanasopoulos-Papadamis.
- Lampropoulos, G.K., y Spengler, P.M. (2002). Introduction: Reprioritizing the role of science in a realistic version of the scientist-practitioner model, *Journal of Clinical Psychology*, 58, 1195-1197.
- Lampropoulos, G.K., Goldfried, M.R., Castonguay, L.G., Lambert, M.J., Stiles, W.B., Nestoros, J.N. (2002). What kind of research can we realistically expect from the practitioner?, *Journal of Clinical Psychology*, 58, 1241-1264.
- Macran, S., y Shapiro, D.A. (1998). The role of personal therapy for therapists: a review. *British Journal of Medical Psychology*, 71, 13-25.
- Manos, N. (1997). *Basika stoixeia klinikis psychiatrikis (Basic Elements of Clinical Psychiatry)*. Thessaloniki: University Studio Press.
- Martin, U., y Schinke, S.P. (1998). Organizational and individual factors influencing job satisfaction and burnout of mental health workers. *Social Work & Health Care*, 28, 51-62.
- McCrindle, D., Wildgoose, J. y Tillett, R. (2001). A survey of psychotherapy training for psychiatric trainees in South-West England. *Psychiatric Bulletin*, 25, 140-143.
- Nestoros, J.N. y Vallianatou, N.G. (1990/1996). *Synthetiki Psychotherapia (Integrative psychotherapy)*. Athens: Ellinika Grammata.
- Nestoros, J.N. (1997a). Integrative psychotherapy of individuals with schizophrenic symptoms. En P.J. Hawkins, y J.N. Nestoros (Eds), *Psychotherapy: New perspectives on theory, practice and research*. Athens: Ellinika Grammata, pp. 321-363.
- Nestoros, J.N. (1997b). A model of training in the methodology of individual psychotherapy research: The case of schizophrenia as a paradigm. En P.J. Hawkins y J. N. Nestoros (Eds), *Psychotherapy: New perspectives on theory, practice, and research*. Athens: Ellinika Grammata, pp. 633-681.
- Nestoros, J.N. (1997c). Research methodology in psychotherapy. *6th Panhellenic Congress of Psychological Research*, Athens, Greece, p. 55.
- Nestoros, J.N. (1998). Research methodology in psychotherapy: Current trends, *Psychology*, 5, 179-188.
- Nestoros, J.N. (2000). Modern "Amphiaraia" in the Greek periphery. In G. Thill (Ed.), *Sustainable Development in the Islands and the Roles of Research and Higher Education*. Vol.2 (pp. 159-165).
- Namur: Coordination Scientifique de PRELUDE.
- Nestoros, J.N. (2001). Synthetiki Psychotherapy: An integrative psychotherapy for individuals with schizophrenic symptoms. *Journal of Contemporary Psychotherapy*, 31, 51-59.
- Nestoros, J.N., Kalaitzaki, A.E., y Zgantzouri, K.A. (1999, September). Personal development of

- the therapist as a consequence of his professional activity. *IXth European Conference on Developmental Psychology*. Island of Spetses, Greece, PS10-25, pp.349-350.
- Nestoros, J.N., Lampropoulos, G.K., y Vallianatou, N.G. (1997). *Synthetiki Psychotherapia: A Greek Approach to Psychotherapy Integration*. *Archives A.P.P.A.C.*, 4, 2, 52-74.
- Nestoros, J.N., Patakou-Parasiri V., Sfakianakis G.S., y Vasdekis V.G.A. (1998). Hypnosis in Greece. En P.J. Hawkins, y M. Heap (Ed.), *Hypnosis in Europe*. London: Whurr Publishers.
- Nestoros, J.N., Vasdekis, V.G.S, Pattakou-Parassiri, V., y Sfakianakis, G. (1998). Clinical Hypnosis in Ancient and Modern Greece. In: Hawkins, P.J. and Heap, M. (eds.), *Hypnosis in Europe* (pp. 99-117). London: Whurr Publishers Ltd.
- Nestoros, J.N., Zgantzouri, K.A., y Lampropoulos, G.K. (1999). *Synthetiki Psychotherapia: Apo ti theoría stin efarmogi (Integrative psychotherapy: From theory to practice)*. In: P. Asimakis (ed.), *Sichrones psychotherapies stin Ellada (Contemporary Psychotherapies in Greece: From theory to practice)* (pp. 325-378). Athens: Institute for Personal Development and University of Indianapolis Athens Press.
- Nickelson, D. (1998). Telehealth and the Evolving Health Care System: Strategic Opportunities for Professional Psychology. *Professional Psychology: Research and Practice*, 29, 527-535.
- Norcross, J.C., y Goldfried, M.R. (1992). *Handbook of Psychotherapy Integration*. New York: Basic Books.
- Papadatos, J., y Stogiannidou, A. (1998). *Community Mental Health*. Athens. Litsas Publ.
- Papadopoulos, N.G. (1994). *Leksiko tis Psychologias (Dictionary of Psychology)*. Athens.
- Paraskevopoulos, I.N. (1988). *Kliniki Psychologia (Clinical Psychology)*. Athens.
- Platrites, K.N. (1995, July).
- Psychotherapy research in Greece: An overview of communications in scientific meetings. *IV European Congress of Psychology*, Athens, July 2-7, Proceedings, S-THR.06.4, p. 570.
- Ploumpidis, D. (1984). Ta prota bimata kai i diadosi tis psychanalysis stin Ellada, i psychoanalytic praktiki kai i anakopi tis giro sto 1950 (The first steps and the spread of psychoanalysis in Greece, Psychoanalytic practice and its inhibition at about 1950). En Th. Tzavaras (ed.) *Psixanalisi kai Ellada: Stoixeia, theseis, erotimata (Psychoanalysis and Greece: Elements, aspects, questions)* (pp. 53-85). Athens: Zaxaropulos-Athanasopoulos-Papadamis.
- Ravitz, P. y Silver, I. (2004). Advances in psychotherapy education. *Canadian Journal of Psychiatry*, 49, 230-237.
- Reid, Y., Johnson, S., Morant, N., Kuipers, E., Szmukler, G., Bebbington, P., Thornicroft, G., y Prosser, D. (1999). Improving support for mental health staff: a qualitative study. *Social Psychiatry & Psychiatric Epidemiology*, 34, 309-15.
- Spengler, P.M., Strohmer, D.C., Dixon, D.N., y Shivy, V.A. (1995). A scientist-practitioner model of psychological assessment: Implications for training, practice and research, *The Counseling*

Psychologist, 23 (3), 506-534.

-Strupp, H.H. (1989). Can the practitioner learn from the researcher?, *American Psychologist*, 44, 717-724.

-Tsouras, S. (1980), *Istoria tis Iatrikis (History of Medicine)*. Thessaloniki: Paratiritis.

-Weinstein, E. (1998). Elements of the art of practice in mental health. *American Journal of Occupational Therapy*, 52, 579-585.

-Xartokollis, P. (1986). *Eisagogi stin Psychiatriki (Introduction in Psychiatry)*. Athens: Themelio.

-Yager, J., y Bienenfeld, D. (2003). How competent are we to assess psychotherapeutic competence in psychiatric residents?, *Academic Psychiatry*, 27, 174-81.